

---

# Laporan Jaga Mahasiswa RSUI

Selasa, 6 Oktober 2026

Koas Jaga: Nama Koas

DPJP Jaga: dr. ....

Narasumber Laporan Jaga: .....



# Total Kasus Baru

| No. | Inisial, usia     | Diagnosis                                                                                                                                                                                                | PAT                | Emergency |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 1   | An. EA, 6thn 9bln | <ul style="list-style-type: none"><li>• Febris H5 e.c Influenza A</li><li>• Anemia mikrositik hipokromik e.c. susp. thalassemia mayor</li><li>• Perawakan normal, Gizi baik</li></ul>                    | Gangguan sirkulasi | Urgent    |
| 2   | By. A, 9bln       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Anemia gravis e.c. susp. Thalassemia mayor dd/ ADB</li><li>• Berat badan normal, perawakan sangat pendek, gizi lebih</li><li>• Imunisasi tidak lengkap</li></ul> | Gangguan sirkulasi | Urgent    |
| 3   | An. IP, 3thn 9bln | <ul style="list-style-type: none"><li>• Anemia mikrositik hipokromik e.c. susp. ADB</li><li>• Febris H6 e.c. influenza A</li></ul>                                                                       | Stabil             | False     |

# Identitas

---

Nama: An. EA

Usia: 6 tahun 9 bulan

Jenis kelamin: Perempuan

Nomor RM: 00399824

Tempat tinggal: BSI 1 Pengasinan Sawangan Depok

## **KELUHAN UTAMA**

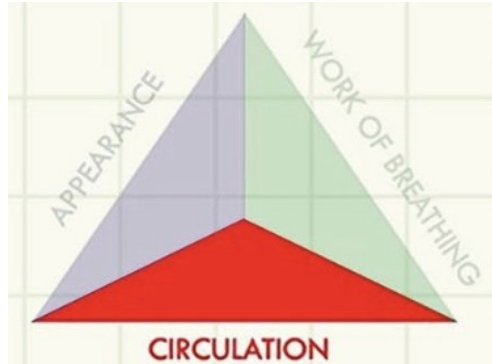
Pucat dan lemas sejak 4 hari SMRS



# Segitiga Asesmen Gawat Anak

## Tampilan

- ☐ Tonus (+)
- ☐ Respon (+)
- ☐ Interaktif (+)
- ☐ Kontak mata (+)
- ☐ Suara/Tangisan(+)



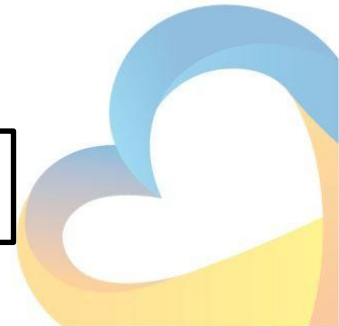
## Upaya napas

- ☐ Napas cuping hidung (-)
- ☐ suara napas tambahan (-)
- ☐ Retraksi (-)
- ☐ posisi abnormal (-)

## Sirkulasi

- ☐ Sianosis (-)
- ☐ Pucat (+)
- ☐ kutis marmorata (-)

**KESAN: Gangguan Sirkulasi**



# Survei Primer

---

- *Airway: clear*
- *Breathing: simetris, RR 22 kali/menit, SpO2 99% RA*
- *Circulation: Klinis pucat, HR 112 kali/menit, TD 93/67 mmHg, CRT<2,*
- *Dissability: GCS E4M6V5*
- *Exposure: T 37,3 C*



# Survei Primer

---

- *Allergy: -*
- *Medication: Paracetamol*
- *Past Illness: Anemia berulang*
- *Last Meal: makan biasa 5 jam SMRS*
- *Event Lead: Demam 4 hari SMRS*



# Riwayat Penyakit Sekarang

---

Pasien datang ke IGD dengan keluhan pucat dan lemas sejak 4 hari SMRS. Keluhan disertai demam 40,3C dengan batuk tanpa adanya mual maupun muntah. Pasien lebih banyak berbaring dan mengalami penurunan nafsu makan (hanya 4-5 sendok setiap makan) serta mulai mengigau sejak pertama kali keluhan muncul. Keluhan demam tidak disertai sesak napas, kejang, pilek, atau keluar cairan dari telinga. Pasien sudah dibawa ke klinik tugu pada hari jumat dan mendapat supositoria, namun keluhan tidak membaik. Pasien pagi hari ini (6 Oktober 2026) dibawa cek lab secara pribadi di klinik FKTP karena keluhan tidak membaik dan didapatkan Hb 4,7 hingga akhirnya datang ke IGD RSUI secara mandiri.

Keluhan gusi berdarah, mimisan, perdarahan gusi, atau perdarahan di tempat lainnya disangkal. Pasien memiliki riwayat transfusi berulang pada usia 2, 3 dan 5 tahun, namun hingga saat ini masih belum diketahui penyebab anemia pada pasien.

# Survei Sekunder

---

## Riwayat Penyakit Dahulu

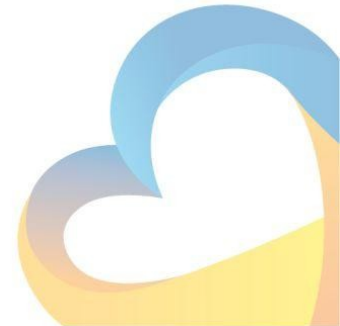
Pasien mengalami keluhan serupa dan memerlukan transfusi darah pada usia 2, 3, dan 5 tahun, memakai 2 kantong darah setiap transfusi.

Satu bulan SMRS, pasien mulai mengalami batuk kering yang memberat saat malam hari dan membuat pasien terbangun pada malam hari selama 5 hari.

## Riwayat Penyakit Keluarga

Tidak ada riwayat penyakit serupa di keluarga. Adik perempuan pasien berusia 3 tahun, dikatakan sehat.

Tidak ada riwayat alergi atau sakit berat pada ayah dan ibu pasien.



# Survei Sekunder

---

## Kehamilan dan Persalinan

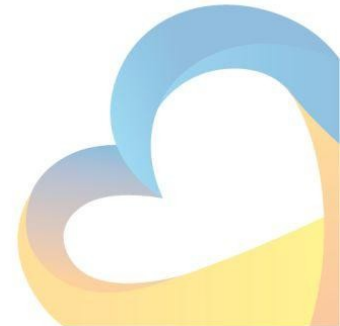
Pasien anak pertama dari 2 bersaudara, lahir normal cukup bulan, berat dan panjang lahir tidak diketahui.

## Riwayat imunisasi

Ayah tidak mengetahui pasti imunisasi pasien, dikatakan lengkap

## Riwayat sosial

Pasien saat ini menjalani pendidikan TK.



# Survei Sekunder

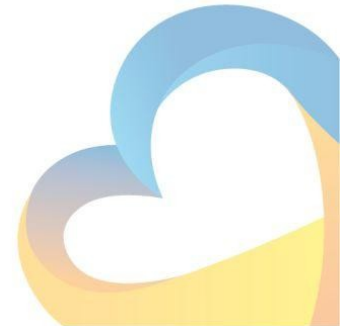
---

## Nutrisi

Pasien makan 3x sehari dengan variasi daging ayam, sayur, dan ikan lele. Menjelang manifestasi gejala, pasien diberikan buah bit, suplemen zat besi, dan daging merah, namun tidak terdapat perbaikan gejala. Pasien diberikan ASI selama 2 tahun tanpa diganti susu formula. MPASI dimulai setelah 6 bulan.

## Riwayat tumbuh kembang

- BB 19kg, TB 115cm
- Tumbuh kembang sesuai usia
- Pasien dapat beraktivitas mandiri (makan, minum, membantu pekerjaan rumah) dan aktif bermain





- [illegible]

Jl. Prof Bahder Djohan, Kampus UI, Depok



# Pemeriksaan Fisis

---

- Keadaan Umum: Tampak sakit sedang
- Kesadaran: GCS15 E4M6V5
- Laju nadi: 112x/menit, reguler, teraba kuat, isi cukup
- Tekanan darah: 93/67 mmHg
- Laju napas: 22x/menit, reguler, napas dalam, abdominotorakal
- Saturasi Oksigen: 99% on RA
- Suhu: 37,3C



| Organ       | Deskripsi                                                                                                                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kepala      | Normocephali                                                                                                                                                                        |
| Wajah       | Tidak ada dismorfik, gerakan wajah kesan simetris, tidak ada moon-face. <b>Terdapat karakteristik facies Cooley (pangkal hidung rendah, wajah bagian tengah datar,iltrum halus)</b> |
| Mata        | <b>Konjungtiva anemis</b> , sklera tidak ikterik, gerakan bola mata baik, palpebra tidak edema, pupil isokor, refleks cahaya langsung dan tidak langsung (++/++)                    |
| Mulut       | <b>Bibir dan mukosa basah namun tampak pucat</b> , tidak terdapat sianosis, tidak ada coated tongue, faring tidak hiperemis, tidak terdapat sariawan                                |
| Leher       | KGB tidak teraba, Tiroid tidak membesar                                                                                                                                             |
| Jantung     | S1-S2 reguler, tidak ada murmur, tidak ada gallop                                                                                                                                   |
| Paru        | Paru mengembang simetris, vesikuler (+/+), ronki (+/+), wheezing (-/-)                                                                                                              |
| Abdomen     | Supel, bising usus positif. Datar, supel, <b>nyeri tekan (+) epigastrium, splenomegali teraba schuffner 2.</b>                                                                      |
| Ekstremitas | Akral hangat, CRT <2s, Tidak ada edema, Turgor kulit baik                                                                                                                           |

# Pemeriksaan penunjang



No. Lab : 2610060776  
No. MR : 00399824  
Nama : ELSHANUM AURI HAZNA, AN  
Tgl Lahir / Umur : 29-01-2020 / 6 tahun 8 bulan 7 hari  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat / Ruangan : -  
Diagnosa : -

Dokter : dr. Yasmia Shabrina Wiryaningih  
Tgl Transaksi : 06-10-2026 15:51:24  
Tgl Bahan Diterima : 06-10-2026 15:52:12  
Tgl Hasil Selesai : 06-10-2026 17:13:09  
Halaman : 1 / 1

| Jenis Pemeriksaan | Hasil | Satuan | Nilai Rujukan |
|-------------------|-------|--------|---------------|
|-------------------|-------|--------|---------------|

## KIMIA DARAH

Glukosa Sewaktu  
Glukosa Sewaktu N 112 mg/dL <140

## HEMATOLOGI (DARAH)

### Hematologi Lengkap

|                    |        |                     |              |
|--------------------|--------|---------------------|--------------|
| Hematologi Lengkap |        |                     |              |
| Hemoglobin         | LL 4.8 | g/dL                | 11.5 - 15.5  |
| Hematokrit         | L 14.4 | %                   | 35.0 - 45.0  |
| Eritrosit          | L 2.7  | 10 <sup>6</sup> /µL | 4.0 - 5.2    |
| MCVVER             | L 54   | fL                  | 77 - 95      |
| MCH/HER            | L 17.9 | pg                  | 25 - 34      |
| MCHC/KHER          | N 33.3 | g/dL                | 31.0 - 37.0  |
| Jumlah Trombosit   | N 196  | 10 <sup>3</sup> /µL | 170 - 450    |
| Jumlah Leukosit    | L 4.80 | 10 <sup>3</sup> /µL | 5.00 - 13.00 |

Kesimpulan:  
Anemia Mikrositik Hipokromik  
Leukopenia  
Positif infeksi Influenza A



No. Lab : 2610060776  
No. MR : 00399824  
Nama : ELSHANUM AURI HAZNA, AN  
Tgl Lahir / Umur : 29-01-2020 / 6 tahun 8 bulan 7 hari  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat / Ruangan : -  
Diagnosa : -

Dokter : dr. Yasmia Shabrina Wiryaningih  
Tgl Transaksi : 06-10-2026 19:10:38  
Tgl Bahan Diterima : 06-10-2026 19:11:58  
Tgl Hasil Selesai : 06-10-2026 19:28:10  
Halaman : 1 / 1

| Jenis Pemeriksaan | Hasil | Satuan | Nilai Rujukan |
|-------------------|-------|--------|---------------|
|-------------------|-------|--------|---------------|

## LAIN - LAIN

### RAPID FLU 4 PARAMETER

#### RAPID FLU 4 PARAMETER

|                   |           |         |
|-------------------|-----------|---------|
| Rapid Influenza A | * Positif | Negatif |
| Rapid Influenza B | N Negatif | Negatif |
| RSV               | N Negatif | Negatif |
| hMPV              | N Negatif | Negatif |

NOTE:

# Diagnosis akhir

- Febris H5 e.c Influenza A
- Anemia mikrositik hipokromik e.c. susp. thalassemia mayor
- Perawakan normal, Gizi baik



# Tatalaksana

## Tata laksana IGD:

- Transfusi PRC bertahap
  - $\text{Volume (mL)} = \text{dHb (target 6 g/dL)} \times \text{BB} \times 4 = (6\text{g/dL} - 4.8\text{g/dL}) \times 19\text{ kg} \times 4 = 91,2\text{ mL}$
  - $\text{Prevensi Transfusion-Associated Circulatory Overload (TACO)} = 10\text{--}15\text{ mL/kg/dosis} = 15\text{ mL/kg} \times 19\text{ kg} = 285\text{ mL mL}$
  - Jika sudah mencapai 6 g/dL, target diubah menjadi 12 g/dL
  - $\text{Volume (mL)} = \text{dHb (target 12 g/dL)} \times \text{BB} \times 4 = (12\text{ g/dL} - 6\text{g/dL}) \times 19\text{ kg} \times 4 = 456\text{ g/dL}$
  - Transfusi 285 mL terlebih dahulu selama 3-4 jam, dilanjutkan 171 g/dL di hari berikutnya

# Tatalaksana

Tata laksana IGD:

- Cairan rumatan KA-EN 1B
  - 100 mL/kg/hari (10 kg pertama) =  $100 \times 19 = 1.9$  L/hari
  - 50 mL/kg/hari (9 kg) =  $50 \times 9 = 450$  mL/hari
  - Total: 2.35L/hari = ~100mL/jam
  - 60 tetes/1 mL x 100 mL/jam = 6000 tetes/jam = 100 tpm



# Tatalaksana

## Antipiretik

- Paracetamol 10–15 mg/kgBB/kali = 190–285 mg per dosis, diulang setiap 6–8 jam. Sediaan sirup 120 mg/5 ml dapat diberikan sebanyak 1,5–2 sendok takar



# Tatalaksana

Rencana diagnosis:

- Thalassemia
  - Apusan darah tepi -> eritrosit mikrositik hipokromik dengan poikilocytosis, sel target, dan basophilic stippling
  - Hitung retikulosit -> normal atau meningkat sedikit
  - Uji hemolisis -> peningkatan LDH, hiperbilirubinemia tidak terkonjugasi, haptoglobin rendah.
  - Studi besi -> ferritin, serum besi, TIBC -> eksklusi ADB -> ferritin meningkat
  - Elektroforesis hemoglobin
  - Testing genetik



# Tatalaksana

Rencana monitoring:

- Pantau reaksi transfusi
- Pantau status hemodinamik



---

# Terima kasih

